SDD 251 Sujet n°1

Spécialité : Médecine interne

Date : 23/12/2024
Auteurs : Clémence BOSC (DES psychiatrie, EN 2024), Alexandre LANNOY (DES neurologie, EN 2024), Camille MARTINAUD (DES psychiatrie, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (DES MAR - Toulouse, EN 2023-2024)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Education, prévention
Item(s) en lien avec la station	Item 330 - Prescription médicamenteuse des classes courantes
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 251 - Prescription de corticoïdes par voie locale et générale
Matériel nécessaire à la station	1 table, 2 chaises
Contexte de la station	Initiation de traitement à l'hôpital

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en médecine générale en stage en rhumatologie, et vous recevez Mme N., 71 ans, d'origine Antillaise. Cette patiente a présenté des douleurs inflammatoires des épaules et des hanches. Une pseudopolyarthrite rhizomélique a alors été diagnostiquée compte-tenu du bilan réalisé.

Elle n'a pas d'autre antécédent et ne prend pas d'autre traitement.

Vous souhaitez initier un traitement au long cours par corticoïdes per os.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Énoncer les éléments à rechercher à l'examen physique dans ce contexte
- Énoncer les éléments du bilan paraclinique nécessaire préalablement à la corticothérapie
- Proposer les mesures préventives et/ou thérapeutiques appropriées dans ce contexte

Vous ne devez pas :

- Expliquer les modalités de prise de traitement
- Planifier le suivi
- Réaliser de prescription
- Examiner de patient

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé (PS) ni professionnel de santé standardisé (PSS).

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques	
1.	Recherche un foyer infectieux et/ou la température Recherche de la fièvre
2.	Vérifie l'état buccodentaire. Énonce la recherche de foyers infectieux dentaires Énonce la recherche d'infections dentaires
3.	Mesure la pression artérielle. Réalise une mesure tensionnelle
4.	Mesure le poids ou calcule l'IMC.
5.	Prescrit un bilan biologique comprenant : - une exploration des anomalies lipidiques (EAL) - une glycémie à jeun - une calcémie - une kaliémie - un dosage de la vitamine D/25 OH-D3 *(au moins 4 éléments sur 5 pour avoir le point)*
6.	Prescrit un électrocardiogramme
7.	Prescrit une ostéodensitométrie.
8.	Évoque la nécessité d'une activité physique régulière
9.	Évoque la limitation des apports sodés ou/et en sucres rapides ou évoque un régime méditerranéen
10.	Propose d'enrichir le régime en calcium ou/et en protides / protéines
11.	Propose un déparasitage à l'ivermectine. Propose un traitement à l'ivermectine
12.	Propose une vaccination contre la grippe.
13.	Propose une vaccination contre le pneumocoque
14.	Propose un traitement anti-ostéoporotique (biphosphonate ou tériparatide)
Communications et attitudes	

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL

Corticothérapie
Les contre-indications sont relatives : ▫ Infections récentes ou patentes (groupe herpès, tuberculose…) ▫ Allaitement : ok si < 30 minutes et > 4 heures d'écart
Bilan initial si prolongé : - Poids, IMC, PA, recherche de foyer infectieux - NFS, EAL, glycémie à jeun et HbA1c, ionogramme sanguin et bilan phosphocalcique - ECG, RTX, ostéodensitométrie si > 3 mois **penser au panoramique dentaire si biphosphonates** - EPS si séjour récent ou patient originaire d'une région tropicale
Effets indésirables : **-** Rétention HS, intolérance au glucose, obésité -fascio-tronculaire), hyperlipidémie - Ostéoporose CTC induite, myopathie des ceintures, rupture tendineuses, cutané (atrophie, hypertrichose et hyperplasie sébacée, acné et eczéma) (**tardif**) - Retard staturo-pondéral de l'enfant, aménorrhée et impuissance - Neuropsychique (insomnie, exaltation : **précoce**), oculaire (glaucome, cataracte sous-capsulaire postérieure) - Dyspepsie, ulcère, infection (**précoce**) - Arrêt : insuffisance surrénalienne, fatigue, faiblesse (**si prolongé**)
RHD et mesures associées : **1) Alimentation :** moins de sel et de sucres rapides, plus de protéines et calcium 2) **Sport** 3) Traitements associés : * ivermectine (pour tout le monde en France) * vaccination grippe et pneumocoque, zona +/- COVID * calcium/vitamine D systématique sauf si hypercalcémie * traitement anti-ostéoporotique (> 3 mois + > 7,5 mg/j, > 70 ans, T<-2.5, ATCD fracture faible cinétique) 4) **Pas d'arrêt brutal, consulter si fièvre ou douleurs abdominales**
Suivi cardiovasculaire et infectieux : - PA, poids, suivi ophtalmologique - K 1-2 mois, glycémie régulière et EAL à 6 mois - 24 OHD2 et D3 (non recommandé quand traitement par vitamine D systématique) - ODM à 1 an en l'absence de traitement anti-ostéoporotique

Bonus : Le diabète corticoinduit prédomine le soir ou l'après-midi, le mieux pour le rechercher est un cycle glycémique vers J10-J15, la GAJ peut être normale